Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 21–24 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

Les valeurs dans la thérapie d'acceptation et d'engagement et les catégories de valeurs de Frankl

Convergences et différences entre deux conceptions des valeurs

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Les valeurs occupent une position centrale aussi bien dans la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) que dans la logothérapie. Dans l'ACT, les valeurs sont comprises comme des qualités de l'action en cours, librement choisies et construites verbalement, qui guident le comportement engagé et donnent une direction à la flexibilité psychologique. Viktor E. Frankl, en revanche, distinguait des valeurs créatrices, des valeurs d'expérience et des valeurs d'attitude, qui selon lui ne sont pas inventées, mais découvertes dans chaque situation. Cet article théorique compare systématiquement les deux conceptions. Il identifie des convergences, telles que la distinction entre valeurs et objectifs, l'accent mis sur l'action et l'engagement, l'importance des valeurs face à une souffrance inévitable et la fonction des valeurs comme contrepoids à une thérapie exclusivement orientée vers les symptômes. Il met en même temps en évidence des différences fondamentales, qui découlent d'arrière-plans philosophiques distincts : le contextualisme fonctionnel de l'ACT d'une part, l'anthropologie phénoménologique et personnaliste de Frankl d'autre part. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si les valeurs sont choisies ou découvertes, ainsi qu'au statut des valeurs d'attitude. L'article se conclut par des réflexions sur la manière dont les deux traditions peuvent apprendre l'une de l'autre sans brouiller leurs prémisses respectives.

Mots-clés : thérapie d'acceptation et d'engagement · valeurs · logothérapie · valeurs d'attitude · flexibilité psychologique

ABSTRACT

Values occupy a central position in both acceptance and commitment therapy (ACT) and logotherapy. In ACT, values are understood as freely chosen, verbally constructed qualities of ongoing action that guide committed behavior and give direction to psychological flexibility. Viktor E. Frankl, in contrast, distinguished creative, experiential, and attitudinal values, which, in his view, are not invented but discovered in the respective situation. This theoretical paper systematically compares the two conceptions. It identifies convergences, such as the distinction between values and goals, the emphasis on action and engagement, the significance of values in dealing with unavoidable suffering, and the function of values as a counterweight to an exclusively symptom-oriented therapy. At the same time, it highlights fundamental differences that arise from distinct philosophical backgrounds: the functional contextualism of ACT on the one hand and Frankl's phenomenological and personalist anthropology on the other. Particular attention is paid to the question of whether values are chosen or discovered and to the status of attitudinal values. The paper concludes with reflections on how both traditions can learn from each other without blurring their respective premises.

Keywords: acceptance and commitment therapy · values · logotherapy · attitudinal values · psychological flexibility

1 Introduction

Dans la psychothérapie des dernières décennies, le concept de valeurs a connu une renaissance remarquable. La thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT), qui fait des valeurs l'un de ses six processus centraux, y a largement contribué (Hayes et al., 1999, 2012). Pour les lecteurs familiers de la logothérapie, cette évolution présente un intérêt particulier, car Frankl avait déjà développé, des décennies plus tôt, une théorie des valeurs qui se trouve au centre de son approche psychothérapeutique (Frankl, 1946).

L'hypothèse, qui vient spontanément à l'esprit, selon laquelle il s'agirait de deux variantes d'une même idée fondamentale reste toutefois insuffisante. Les deux traditions sont nées dans des contextes

épistémologiques et anthropologiques différents, et les mêmes termes y revêtent parfois des significations différentes. La présente contribution compare les deux conceptions afin de nommer précisément les points communs et d'éviter un nivellement prématuré des différences.

La comparaison procède en quatre étapes. Le concept de valeurs de l'ACT est d'abord situé dans son contexte théorique, puis la théorie des valeurs de Frankl est esquissée. Sur cette base, les convergences et les différences sont dégagées. Enfin, les implications pour la pratique, l'évaluation et la recherche sont discutées. La contribution se limite au niveau conceptuel et ne se prononce pas sur l'efficacité comparée des deux approches.

2 Les valeurs dans la thérapie d'acceptation et d'engagement

L'ACT se conçoit comme une application du contextualisme fonctionnel et de la théorie des cadres relationnels, une approche issue de l'analyse du comportement visant à expliquer le langage et la cognition humains (Hayes et al., 2001). Selon cette conception, la souffrance psychique naît essentiellement de l'inflexibilité psychologique, c'est-à-dire de la domination de règles verbales rigides, de stratégies d'évitement expérientiel et d'un rétrécissement du répertoire comportemental (Hayes et al., 2006). La flexibilité psychologique, à l'inverse, est considérée comme un aspect fondamental de la santé mentale (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Dans l'ACT, les valeurs sont décrites comme des conséquences librement choisies et construites verbalement de schémas d'activité continus et évolutifs, qui fonctionnent comme des renforçateurs et donnent une direction à l'action (Hayes et al., 2012). La distinction entre valeurs et objectifs est essentielle : les objectifs peuvent être atteints et menés à terme, alors que les valeurs ressemblent à une direction de boussole sur laquelle on s'oriente sans jamais arriver. Les valeurs ne doivent en outre pas découler du devoir, de la pression sociale ou du désir d'éviter la douleur, mais être vécues comme personnellement significatives. Des instruments spécifiques ont été développés pour évaluer l'action guidée par les valeurs, tels que le Valued Living Questionnaire (Wilson et al., 2010).

Dans le travail thérapeutique en ACT, les valeurs sont souvent explorées au moyen d'exercices expérientiels, par exemple en imaginant ses propres funérailles ou en se demandant ce que l'on veut incarner dans la vie (Hayes et al., 1999). La clarification des valeurs n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu étroitement lié à l'action engagée. On veille en même temps à ne pas ériger les valeurs en nouvelles règles rigides, qui pourraient à leur tour conduire à l'inflexibilité.

3 Les catégories de valeurs de Frankl

Frankl distinguait trois voies principales par lesquelles les personnes peuvent réaliser du sens (Frankl, 1946, 1955). Les valeurs créatrices se réalisent dans ce qu'une personne donne au monde, par exemple par le travail ou la création. Les valeurs d'expérience se réalisent dans ce qu'une personne reçoit du monde, par exemple dans la rencontre avec la nature, l'art ou un autre être humain. Les valeurs d'attitude, enfin, se réalisent dans l'attitude qu'une personne adopte face à un destin inéluctable, en particulier face à une souffrance inévitable.

Pour Frankl, le sens et les valeurs ne sont pas inventés, mais trouvés. Selon sa conception, le sens se rapporte toujours à une situation concrète et s'adresse comme un appel à la personne singulière, qui y répond de manière responsable (Frankl, 1969). La conscience fonctionne ici comme « organe du sens », capable de pressentir le sens unique d'une situation. Cette conception s'inscrit dans une anthropologie qui postule une dimension spirituelle de l'être humain et considère l'autotranscendance – l'orientation vers quelque chose ou quelqu'un au-delà de soi-même – comme la marque distinctive de l'existence humaine.

Les catégories de valeurs de Frankl ne doivent pas être comprises au sens d'une hiérarchie rigide ; il attribuait néanmoins une dignité particulière aux valeurs d'attitude, parce qu'elles peuvent encore être réalisées là où les possibilités créatrices et d'expérience sont épuisées. C'est là que réside la pointe de sa thèse du caractère inconditionnellement sensé de la vie : tant qu'une personne vit, il lui reste au moins la possibilité de prendre position face à son destin (Frankl, 1946).

4 Convergences

Malgré leurs origines différentes, plusieurs convergences peuvent être identifiées. Premièrement, les deux approches soulignent la distinction entre une direction englobante et des objectifs concrets. La manière dont Frankl parle du sens comme d'une tâche qui se pose à nouveau dans chaque situation et la métaphore de la direction de boussole de l'ACT indiquent toutes deux que les valeurs ne peuvent être cochées sur une liste. Deuxièmement, les deux traditions mettent l'accent sur l'action et l'engagement

plutôt que sur la simple prise de conscience. Troisièmement, toutes deux voient dans les valeurs un contrepoids à une thérapie orientée exclusivement vers la réduction des symptômes.

Le plus frappant est leur proximité dans la manière d'aborder la souffrance inévitable. L'ACT invite les personnes à ne pas combattre les expériences intérieures douloureuses, mais à les accepter au service d'une action guidée par les valeurs. Les valeurs d'attitude de Frankl visent une attitude apparentée : là où une situation ne peut être changée, demeure la liberté de prendre position à son égard. Dans les deux cas, faire face à la souffrance est compris non comme sa suppression, mais comme une transformation de son rapport à elle.

5 Différences

La différence la plus fondamentale concerne le statut des valeurs. Dans l'ACT, les valeurs sont choisies ; leur signification résulte de leur fonction pour l'action d'une personne, et le contextualisme fonctionnel s'abstient délibérément de tout énoncé ontologique sur la question de savoir si les valeurs existent indépendamment des êtres humains (Hayes, 2004). Pour Frankl, en revanche, les valeurs et le sens ne peuvent être choisis arbitrairement, mais possèdent un caractère d'exigence qui s'impose à la personne de l'extérieur. Cette différence n'est pas seulement terminologique : elle a des conséquences pour la question de savoir si un thérapeute peut interroger les valeurs d'un client, ainsi que pour la signification de la responsabilité et de la conscience.

Une deuxième différence concerne les valeurs d'attitude. Dans l'ACT, l'acceptation est un processus qui rend possible l'action guidée par les valeurs, mais qui n'est pas elle-même une valeur. Pour Frankl, en revanche, l'attitude face à la souffrance peut elle-même être porteuse de sens – même lorsqu'il n'existe plus d'autres possibilités d'action. Cette position prend un poids particulier dans les situations où la marge d'action est fortement limitée, par exemple en cas de maladie grave en fin de vie.

Une troisième différence concerne le rôle de l'autotranscendance. Avec le soi comme contexte, l'ACT dispose d'une perspective qui conduit au-delà de l'identification aux concepts de soi. L'autotranscendance de Frankl désigne toutefois autre chose : le fait de se tourner vers un sens ou vers une autre personne au-delà de son propre vécu. L'analyse existentielle a elle aussi souligné la prise de position personnelle comme une dimension autonome (Längle, 2013).

Une quatrième différence concerne la relation entre langage et sens. Dans l'ACT, le langage est considéré comme une arme à double tranchant : la capacité à former des cadres relationnels rend possibles les valeurs et l'orientation vers l'avenir, mais elle est en même temps une source de rumination, d'auto-évaluation et d'évitement expérientiel (Hayes et al., 2001). Frankl, en revanche, considère la dimension spirituelle non pas d'abord sous l'angle de ses risques, mais comme source de liberté et de responsabilité. Le scepticisme de l'ACT à l'égard de la domination des règles verbales n'a pas d'équivalent direct en logothérapie, même si la critique franklienne de l'hyperréflexion va dans une direction apparentée.

6 Conclusions

La comparaison montre que l'ACT et la logothérapie sont étonnamment proches dans leur orientation pratique, mais divergent nettement dans leurs fondements philosophiques. Pour la pratique, cela peut être enrichissant : l'ACT offre une multitude d'exercices éprouvés pour clarifier les valeurs et favoriser la flexibilité psychologique ; la logothérapie offre un langage différencié pour aborder la souffrance inéluctable et la question de savoir vers quoi une personne s'oriente au-delà d'elle-même. Pour la recherche se pose la tâche d'opérationnaliser les différences entre les conceptions des valeurs de telle sorte que leurs contributions respectives au changement deviennent empiriquement distinguables. Un mélange éclectique sans réflexion sur les prémisses ne servirait en revanche aucune des deux traditions.

Il en découle des exigences différentes pour la mesure. Les instruments issus de la tradition de l'ACT évaluent typiquement l'importance que revêtent certains domaines de vie pour une personne et la cohérence avec laquelle elle agit en conformité avec eux (Wilson et al., 2010). Des concepts logothérapeutiques tels que la réalisation des valeurs d'attitude ne peuvent être représentés que de manière insuffisante par de tels instruments, puisqu'ils concernent précisément les situations dans lesquelles une action conforme aux valeurs au sens habituel n'est guère possible. Il existe ici un besoin de développement en matière d'évaluation.

Références

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1955). The doctor and the soul: An introduction to logotherapy. Knopf.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639–665.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (Eds.). (2001). Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865–878.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60(2), 249–272.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Values in Acceptance and Commitment Therapy and Frankl's Categories of Values: Convergences and Differences Between Two Conceptions of Values. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 21–24.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.